

細胞障害性抗がん薬

分類・作用機序・臓器毒性

1 薬剤の分類マップ

DNAに作用

DNAを架橋して複製を阻害

アルキル化薬 シクロホスファミド イホスファミド ベンダムスチン テモゾロミド
白金製剤 シスプラチン カルボプラチン オキサリプラチン

代謝拮抗薬

偽の材料でDNA合成を停止

葉酸代謝拮抗薬 メトトレキサート ペメトレキセド ピリミジン代謝拮抗薬 5-FU S-1 カベシタビン ゲムシタビン
プリン代謝拮抗薬 メルカプトプリン フルダラビン

微小管阻害薬

細胞分裂(M期)を停止

タキサン系 パクリタキセル ドセタキセル nab-パクリタキセル
ビンカアルカロイド系 ビンクリスチン ビノレルビン その他 エリブリン

トポ阻害薬

DNAの切断・再結合を阻害

トポイソメラーゼI型 イリノテカン ノギテカン トポイソメラーゼII型 エトポシド

抗腫瘍性抗生物質

DNAに入り込み複製を阻害

アントラサイクリン系 ドキソルビシン エピルビシン アムルビシン その他 プレオマイシン マイトマイシンC

☒ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い) ☐ 注射薬

2 臓器に特有の毒性と予防・対策

心毒性

主な原因薬剤 ドキソルビシン等のアントラサイクリン系(累積投与量に依存)

病院での予防・対策 累積投与量の管理、治療前後の心エコー

薬局で確認すること

息切れ・むくみ・急な体重増加、抗HER2療法の併用歴

腎障害

主な原因薬剤 シスプラチン、大量メトトレキサート

病院での予防・対策 大量補液・Mg補充/尿のアルカリ化・ホリナート救援

薬局で確認すること

処方箋の検査値でクレアチニン、NSAIDs・PPIの併用、水分摂取

出血性膀胱炎

主な原因薬剤 イホスファミド、大量シクロホスファミド

病院での予防・対策 メスナの併用、補液

薬局で確認すること

血尿・排尿時の痛み、1日の水分摂取量

肺毒性

主な原因薬剤 プレオマイシン(総投与量に依存)

病院での予防・対策 総投与量の管理、呼吸機能の確認

薬局で確認すること

咳・息切れ・発熱が続かないか

末梢神経障害

主な原因薬剤 タキサン系、ビンカアルカロイド系、オキサリプラチン

病院での予防・対策 減量・休薬の判断

薬局で確認すること

ボタン・箸・歩行など具体的な動作での変化

血管外漏出

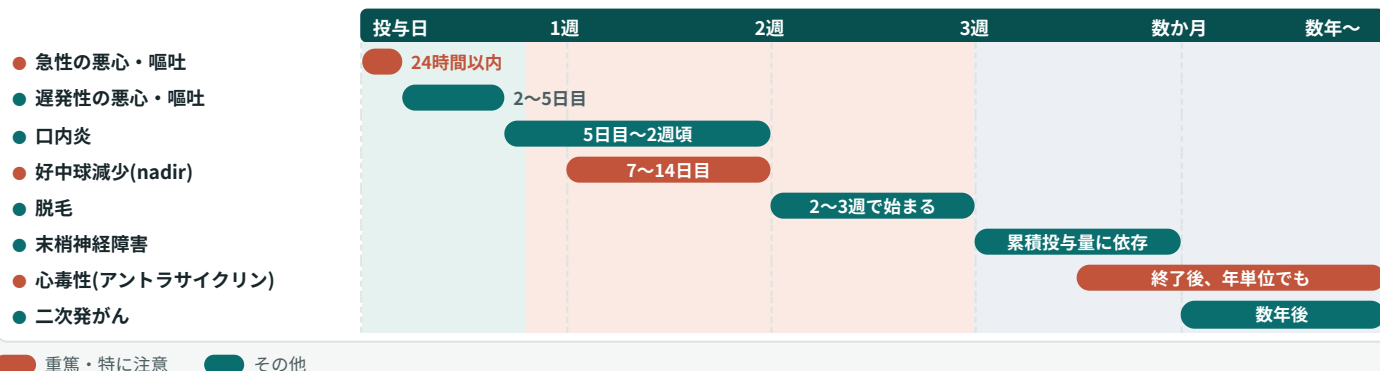
主な原因薬剤 アントラサイクリン系、ビンカアルカロイド系

病院での予防・対策 投与中の観察、漏出時の処置

薬局で確認すること

帰宅後の点滴部位の痛み・赤み・腫れ

3 副作用の特徴と発現時期



押さえておきたいポイント

- 5つのグループと細胞周期上の作用点で整理すると、効き方と副作用が理解しやすい
- 臓器特有の毒性は、病院での累積投与量・腎機能の確認と、薬局での症状の聞き取りの両面で管理
- レジメン・検査値・副作用Grade・服用状況を病院と薬局で共有することが、安全な治療継続の鍵